

■ 回復期リハ／大腿骨近位部骨折×認知機能

大腿骨骨折の回復期リハ、運動FIMの改善は認知機能が高いほど大きい

日本の地域病院・425股の後ろ向き研究 改訂長谷川式1点あたり0.52点、骨折型は傾きに影響せず

2018年1月～2024年12月に、頸部骨折の人工骨頭置換術(平均82.6歳)または転子部骨折の骨接合術(平均86.6歳)後に回復期病棟へ転棟した患者。運動FIM(mFIM)を転棟時と退院時に測り、線形混合効果モデルで解析した。

時間との交互作用が有意だったのは認知機能(改訂長谷川式)だけで、 $B=0.52(95\%CI\ 0.38\sim$

$0.66, P<0.001)$ 。骨折型はmFIMの水準に影響(転棟時→退院時は頸部46.3→65.0、転子部38.4→58.8)したが、傾きには有意差なし($P=0.055$)。

単一施設の後ろ向き研究で、せん妄の記録が不十分。順序尺度を連続量として扱っており、示したのは関連で因果ではない。



認知機能が低い人ほど伸びにくい前提で、関わり方を組み直す材料に

出典 **Progress in Rehabilitation Medicine** ↗

数字で見る

425股

頸部骨折201・転子部骨折224(単一病院・後ろ向き)

0.52点

改訂長谷川式1点あたりのmFIM改善の上乗せ(95%CI 0.38～0.66)

50日

回復期病棟の平均在棟日数(頸部50.0・転子部53.3)

■ 介護報酬改定／退院支援

退院当日の訪問リハは算定不可、リハ協議会が介護報酬改定で要望

主治医が必要と認めた場合に退院・退所当日の訪問を可能にし、自宅の療養環境の整備と退院時共同指導の反映を早める。退院時共同指導加算は、老健などの退所前カンファレンスにも広げるよう求めた。

根拠の一つとして、回復期リハ病棟の退院患者の約3分の2にリハが未導



入だったと記事は述べる(元調査は明記なし)。要望段階で、反映は今後の議論次第。

出典 **PT-OT-ST.NET** ↗

■ 脳卒中／ロボット歩行訓練

歩行ロボット訓練の上乗せ、歩行・ADLは通常の理学療法と差なし

亜急性期・慢性期のどちらでも同様に、歩行持久力の改善は亜急性期のほうが大きい。EQ-5D VASはRAGT併用群で改善が大きく(介入後 $p=0.047$ 、12週後 $p<0.001$)、研究に関連する重篤な有害事象はなし。

対象は歩行できる人が中心で、非歩行者は歩行評価から除外。亜急性期のRAGT併用群は25人中7



人が脱落(他群は各1人)。著者らはRAGTを万能な代替でなく補完的な選択肢とまとめる。

出典 **Frontiers in Neurology** ↗

短信

〈呼吸リハ〉80歳以上の人工呼吸、リハで離脱45%

長期人工呼吸の各75人のRCT。離脱成功45.3%対12.0%(aHR 5.11)。中国の単施設 出典 **Chest** ↗

〈嚥下〉脳卒中の嚥下、動画ゲームで経口摂取が改善

6RCT・309人のMA。FOIS +0.78(95%CI 0.36～1.21)、確実性は低く異質性 $I^2 74\%$ 出典 **Front Neurol** ↗

〈サルコペニア〉缶が開けられない、サルコペニアと関連

通所リハ109人。OR 4.5だがAUC 0.62・感度42.2%で、単独の判定には不向き 出典 **Prog Rehabil Med** ↗

〈脳卒中〉脳卒中の在院日数、脳梗塞17日・脳出血34日

日本の農村ネットワーク303人。在院日数の中央値で、脳梗塞は在宅退院が早い。退院時FIMは自宅退院群が高い 出典 **Medicine** ↗

〈退院支援〉股関節骨折の移行期ケア、促進要因を整理

36研究・17か国の混合研究SR。多職種リハ経路・構造化した退院計画・家族関与が促進要因 出典 **Int J Orthop Trauma Nurs** ↗

〈行政〉厚労大臣がリハ現場を視察、人手不足に言及

9/14に茨城の2病院を視察。「リハビリは攻めの予防医療」と述べ、令和9年度概算要求に関連予算を盛り込んだとした 出典 **PT-OT-ST.NET** ↗

〈上肢ロボット〉ソフトロボットグローブ、通常訓練と差なし

亜急性期58人のRCT。GRASPと群間差なし、資金難で予定症例数に届かず検出力不足 出典 **J Neuroeng Rehabil** ↗

〈高次脳〉プリズム適応+ゲームで半側無視・言語が改善

脳卒中60人のRCT。10回・6か月追跡、対照は紙と鉛筆の訓練。単一の報告 出典 **Ann Phys Rehabil Med** ↗